

ESCALA CURB-65

Estratificación de Gravedad y Elección del Lugar de Cuidados en Neumonía

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

CINCO CRITERIOS CLÍNICOS DE CURB-65

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
C - Confusión Alteración reciente del estado mental	☐ Alterado: Confusión mental de reciente aparición / Test abreviado ≤ 8 (1) ☐ Normal: Estado mental intacto, orientado en tiempo/espacio (0)	[]
U - Urea (BUN) Indicador de disfunción renal	☐ Alterado: Nitrógeno Ureico en Sangre (BUN) > 19 mg/dL (Urea > 7 mmol/L) (1) ☐ Normal: BUN ≤ 19 mg/dL (Urea ≤ 7 mmol/L) (0)	[]
R - Frecuencia Respiratoria Evaluación de taquipnea	☐ Alterado: Frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones/minuto (1) ☐ Normal: Frecuencia respiratoria < 30 respiraciones/minuto (0)	[]
B - Presión Arterial (Blood Pressure) Inestabilidad hemodinámica	☐ Alterado: Presión Sistólica < 90 mmHg o Diastólica ≤ 60 mmHg (1) ☐ Normal: PAS ≥ 90 mmHg y PAD > 60 mmHg (0)	[]
65 - Edad ≥ 65 Años Factor de riesgo por edad avanzada	☐ Paciente con 65 años o más (1) ☐ Paciente menor de 65 años (0)	[]

Recomendaciones de Manejo de la Sociedad Británica de Tórax (BTS):

- Estudio Diagnóstico: Cultivos de esputo y hemocultivos previos a antibióticos, antígeno urinario (Legionella/Neumococo), Rx tórax.
- Oxigenoterapia Objetivo: Titular O₂ para SpO₂ 94-98% (o 88-92% en riesgo de hipercapnia).
- Primera Dosis de Antibiótico: Administrar en < 4 horas (o < 1 hora si CURB-65 ≥ 3 o shock séptico).

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 5) **Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Riesgo Bajo (Grupo 1) (0 - 1 punto)Mortalidad a 30 días $< 1.5\%$. Tratamiento ambulatorio con antibióticos orales.**Riesgo Moderado (Grupo 2) (2 puntos)**

Mortalidad aprox. 9.2%. Ingreso recomendado en sala de hospitalización.

Riesgo Severo (Grupo 3) (3 - 5 puntos)

Mortalidad 15% a 40%. Hospitalización urgente; valorar UCI para puntuaciones 4-5.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación